Decreto 109

APRUEBA EL REGLAMENTO PARA LA CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS ACCIDENTES DEL TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES, DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN LA LEY 16.744, DE 1° DE FEBRERO DE 1968, QUE ESTABLECIÓ EL SEGURO SOCIAL CONTRA LOS RIESGOS POR ESTOS ACCIDENTES Y ENFERMEDADES

MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

Publicación: 07-JUN-1968 | Promulgación: 10-MAY-1968
Versión: Texto Original De : 07-JUN-1968
Inicio Vigencia: 07-JUN-1968
Fin Vigencia: 07-JUN-1968
Url Corta: https://bcn.cl/3gnnt

APRUEBA REGLAMENTO PARA LA CALIFICACION Y EVALUACION DE LOS ACCIDENTES DEL TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES

Santiago, 10 de Mayo de 1968.- Hoy se decretó lo que sigue:
Núm. 109.- Vistos: lo dispuesto por la ley N° 16.744; lo informado por la Superintendencia de Seguridad Social en oficio Nº 1.097, de 25 de Abril del año en curso; y la facultad que me otorga el N° 2 del artículo 72 de la Constitución Política del Estado,

Decreto:

Apruébase el siguiente Reglamento para la calificación y evaluación de los Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales:

Artículo 1° Las prestaciones económicas establecidas en la ley N° 16.744 tienen por objeto reemplazar las rentas de actividad del accidentado o enfermo profesional. Por consiguiente, existirá continuidad de ingresos entre remuneraciones y subsidio o pensión, o entre subsidio y pensión.
El derecho a las prestaciones económicas del seguro se adquirirá a virtud del diagnóstico médico correspondiente.

Artículo 2° Se considerará incapacidad temporal toda aquella provocada por accidente del trabajo o enfermedad profesional, de naturaleza o efectos transitorios, que permita la recuperación del trabajador y su reintegro a sus labores habituales.
No será necesario graduar la incapacidad temporal; y en tanto ella subsista, el trabajador sólo tendrá derecho a las prestaciones médicas y a subsidio, con arreglo al párrafo III del Título V de la ley Nº 16.744.

Artículo 3° Se considerará invalidez el estado derivado de un accidente del trabajo o enfermedad profesional que produzca una incapacidad presumiblemente permanente de naturaleza irreversible, aun cuando deje en el trabajador una capacidad residual de trabajo que le permita continuar en actividad.
La invalidez deberá ser graduada en todo caso, en conformidad a las normas establecidas en el presente reglamento, y en tanto, represente una incapacidad de ganancia igual o superior a un 15% dará derecho a indemnización global o a pensión, según el caso, sin perjuicio de las prestaciones médicas y subsidios que

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile / BCN | Ley Chile

correspondan.

Artículo 4° La declaración, evaluación, reevaluación y revisión de la invalidez será de la exclusiva competencia del Servicio Nacional de Salud, cualquiera que sea el organismo administrador en que se encuentre afiliado el accidentado o enfermo profesional.

Estas resoluciones serán adoptadas por las Comisiones que el Director del Servicio Nacional de Salud cree con este objeto. Las Comisiones estarán integradas, en todo caso, con médicos especialistas, y funcionarán previa citación hecha al organismo administrador correspondiente.

Artículo 5º.- El Director General de Salud deberá comunicar a la Comisión Médica de Reclamos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales la composición de las Comisiones, como asimismo las modificaciones que les introduzca.

Dentro del plazo de sesenta días el Director deberá dictar un reglamento interno para establecer la organización y funcionamiento de las Comisiones, disponiendo las medidas necesarias para su descentralización.

Artículo 6° Las Comisiones, para dictaminar, formarán un expediente con los datos y antecedentes que les hayan sido suministrados, debiendo incluir entre éstos aquellos a que se refiere el inciso 2º del artículo 60 de la ley N° 16.744 y los demás que estime convenientes para una mejor determinación del grado de incapacidad de ganancia.

Las Comisiones, en el ejercicio de sus funciones, podrán requerir de los distintos Departamentos del Servicio Nacional de Salud y de los organismos administradores que correspondan, se les proporcionen los antecedentes señalados en el inciso anterior.

Tratándose de accidentes las Comisiones deberán contar, necesariamente, entre los antecedentes, con la declaración hecha por el organismo administrador de que éste se produjo a causa o con ocasión del trabajo.

Artículo 7° Las Comisiones actuarán a requerimiento del médico tratante cuando éste lo estime procedente; a petición del organismo administrador, particularmente en el caso previsto en el inciso 3º del artículo 31 de la ley Nº 16.744, y a solicitud del interesado.

Artículo 8° En las Comisiones actuará un Secretario, designado por el Director General del Servicio, quien tendrá el carácter de ministro de fe para autorizar las actuaciones y resoluciones de ellas.

Artículo 9° Las resoluciones que dicten las Comisiones serán notificadas a los organismos administradores que correspondan y al interesado, a más tardar dentro del 5º día.

Con el mérito de la resolución, los organismos administradores procederán a determinar las prestaciones que corresponda percibir al accidentado o enfermo, sin que sea necesaria la presentación de solicitud por parte de éste.

La resolución de las Comisiones deberá contener una declaración sobre las posibilidades de cambios en el estado de invalidez, ya sea por mejoría o agravación.

Artículo 10° De las resoluciones que dicten las Comisiones podrá reclamarse ante la Comisión Médica de Reclamos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales en la forma establecida en el artículo 77 de la ley N° 16.744 y en el

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile / BCN | Ley Chile

Título VI del Reglamento General de la misma ley.

Artículo 11° Para los efectos señalados en el inciso 1º del artículo 64 de la ley N° 16.744, el inválido deberá concurrir cada dos años al Servicio Médico respectivo.

Artículo 12° En los períodos intermedios de los controles y exámenes establecidos en el Título VI de la ley N° 16.744, el interesado podrá, por una sola vez, solicitar la revisión de su incapacidad.

Artículo 13° Después de los primeros 8 años, será el organismo administrador quien podrá exigir los controles médicos a los pensionados cuando se trate de accidentes o enfermedades profesionales que por su naturaleza sean susceptibles de experimentar cambios, ya sea por mejoría o agravación.

Artículo 14° La prórroga del período de subsidio a que se refiere el inciso 2° del artículo 31 de la ley N° 16.744 deberá ser autorizada por las Comisiones, a petición del médico tratante. El rechazo deberá ser fundado y puesto en conocimiento del médico tratante y del interesado, en la forma contemplada en el inciso 1° del artículo 9°.

Artículo 15° Los plazos señalados en el artículo 31 de la ley N° 16.744 regirán independientemente para cada enfermedad o accidente que sufra el afiliado, a menos que la segunda enfermedad o accidente sea consecuencia, continuación o evolución de la primera, en cuyo caso los períodos se computarán como uno solo.

Artículo 16° Para que una enfermedad se considere profesional es indispensable que haya tenido su origen en los trabajos que entrañan el riesgo respectivo, aun, cuando éstos no se estén desempeñando a la época del diagnóstico.

Artículo 17.- Las Comisiones a que se refiere el artículo 4º de este reglamento dictaminarán, a petición del interesado, en los casos a que se refiere el artículo 71 de la ley Nº 16.744 cuando la entidad empleadora no le hubiere dado oportuno cumplimiento, y la Dirección del Servicio Nacional de Salud dictará una resolución en tal sentido, la que será obligatoria para la entidad empleadora.

El Servicio Nacional de Salud controlará el cumplimiento de dicha resolución, aplicando cuando procediere las sanciones establecidas en la ley N° 16.744.

Artículo 18° Para los efectos de este reglamento se considerarán los siguientes agentes específicos que extrañan el riesgo de enfermedad profesional.

Agentes específicos	Trabajos que entrañan el riesgo
a) Agentes químicos:	
1) Arsénico y sus compuestos, incluido el hidrógeno arseniado.	Todos los trabajos que expongan al riesgo durante la producción, separación y utilización del agente.
2) Cadmio y sus compuestos.	"
3) Cromo y sus compuestos.	"

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile / BCN | Ley Chile

4) Fósforos, incluidos los pesticidas.	"	
5) Manganeso y sus compuestos.	"	
6) Mercurio y sus compuestos.	"	
7) Plomo y sus compuestos.	"	
8) Otros metales: antimonio, berilio, níquel, vanadio, talio, selenio y telurio.	Todos los trabajos que expongan al riesgo durante la producción, separación y utilización del agente.	
9) Flúor y sus compuestos.	"	
10) Derivados clorados y los hidrocarburos alifáticos y aromáticos, incluidos los pesticidas.	"	
11) Derivados halogenados de los hidrocarburos alifáticos.	"	
12) Bencenio y sus homólogos.	"	
13) Derivados nitrados y aminados del benceno.	"	
14) Alcoholes y ésteres nitrados (nitroglicerina, etc).	"	
15) Sulfuro de carbono.	"	
16) Asfixiantes químicos: -ácidos sulfídrico -ácido cianhídrico y cianuros -monóxido de carbono.	"	
17) Alquitrán y petróleo, sus similares y derivados.	"	
18) Plásticos y sus materias primas.	"	
b) Agentes físicos:		

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile / BCN | Ley Chile

19)	Energía ionizante; Rayos X, radium y radioisótopos.	Todos los trabajos que expongan al riesgo durante la exposición al agente.
20)	Energía radiante; infraroja, ultarvioleta, microonda, radar y laser	"
21)	Ruido y ultrasonido.	
22)	Aumentos o disminución de la presión atmosférica.	Todos los trabajos que expongan al riesgo de descompresión brusca o de hipopresión en altura.
23)	Movimiento, vibración, fricción y comprensión continuos.	Todas las operaciones que expongan al trabajador a la acción de estos agentes.
c)	Agentes biológicos:	
24)	Infecto-contagiosos y parasitarios -Anquilostoma -Bacilo anthrasis -Brucela -Bacilo tuberculoso bovino -Espiroqueta hemorrágica -Rabia -Tétano	Transmitidos al hombre por razón de su trabajo agrícola, pecuario, minero, manufacturero y sanitario.
25)	Insectos ponzoñosos	Transmitidos al hombre por razón de su trabajo agrícola, pecuario, minero, manufacturero y sanitario.
26)	Vegetales -Litre -Hongos -Fibras (algodón, lino y cáñamo).	"
d)	Polvos:	
27)	Sílice libre (cuarzo, etc.).	Todos los trabajos que expongan al riesgo durante la extracción, molienda, fundición, manufactura, uso y reparación con materias primas o sus productos elaborados.
28)	Silicatos (asbestos, talco, etc.).	"

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile / BCN | Ley Chile

29) Carbón mineral (antracida, etc.). "
30) Berilio y metales duros (cobalto, etc.). "

Artículo 19° Se entenderán por enfermedades profesionales las siguientes:

Enfermedades	Trabajos que entrañan el riesgo y agentes específicos
1) Intoxicaciones	Todos los trabajos que expongan al riesgo por acción de agentes químicos (1-16).
2) Dermatosis profesionales	Todos los trabajos que expongan al riesgo por acción de diferentes agentes (1-16-17, 18, 19, 20 y 26).
3) Cánceres y lesiones precancerosas de la piel	Todos los trabajos que expongan al riesgo por acción de agentes físicos y químicos (17, 19 y 20).
4) Neumoconiosis	Todos los trabajos que expongan al riesgo por acción de polvo con:
-Silicosis	Sílice (27)
-Asbestosis	Asbesto (28)
-Talcosis	Talco (29)
-Beriliosis	Berilio (30)
-Neumoconiosis del carbón	Carbón (29)
-Bisinosis	Algodón y lino (26)
-Canabiosis	Cáñamo (26).
5) Bronquitis, neumonitis, enfisema y fibrosis pulmonar de origen químico.	Todos los trabajos que expongan al riesgo por acción de un agente químico (1-18).
6) Asma bronquial.	Todos los trabajos que expongan al riesgo por acción de agentes químicos y biológicos 1-18, 26).
7) Cáncer pulmonar y de las vías respiratorias.	Todos los trabajos que expongan al riesgo por acción de agentes químicos y físicos (1-18, 19)
8) Cáncer y tumores de las vías urinarias.	Todos los trabajos que expongan al riesgo por acción de aminas aromáticas.
9) Leucemia, aplasia medular.	Todos los trabajos que expongan al riesgo de agentes químicos y físicos (12, 19).
10) Lesiones del sistema nervioso central y periférico; encefalitis,	Todos los trabajos que expongan al riesgo por acción de agentes químicos, físicos y biológicos (1-18-22, 24).

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile / BCN | Ley Chile

	mielitis, neuritis y polineuritis.	
11)	Lesiones de los organos de los sentidos.	Todos los trabajos que expongan al riesgo por acción de agentes químicos y físicos (1-18, 19, 20, 21).
12)	Lesiones de los órganos del movimiento (huesos, articulaciones y músculos; artritis, sinovitis, tendinitis, miositis, celulitis y transtornos de la circulación y sensibilidad.	Todos los trabajos que expongan al riesgo por acción de agentes químicos, físicos y biológicos (9, 19, 22, 23 y 24).
13)	Neurosis profesionales incapacitantes	Todos los trabajos que expongan al riesgo de tensión psíquica y se compruebe relación de causa a efecto.
14)	Laringitis profesional con afonía.	Todos los trabajos que expongan al riesgo por tensión fisiológica de las cuerdas vocales.
15)	Enfermedades infecto contagiosas y parasitarias: anquilostomiasis, pústula maligna brucelosis, tuberculosis bovina y aviaria, espiroquetosis, rabia, tétano,	Todos los trabajos que expongan al riesgo de agentes biológicos (24).
16)	Enfermedades generalizadas por acción de agentes biológicos: picaduras de insectos (abejas, arañas, escorpiones).	Todos los trabajos que expongan al riesgo de agentes biológicos animales (25).

Artículo 20.- La Superintendencia de Seguridad Social previo informe del Servicio Nacional de Salud, revisará cada 3 años la nómina de las enfermedades profesionales y de sus agentes, indicada en el artículo anterior y propondrá al Ministerio del Trabajo y Previsión Social las modificaciones que sea necesario introducirle.

Artículo 21.- El Servicio Nacional de Salud dictará las normas de diagnostico que estime procedentes para facilitar y uniformar las actuaciones médicas correspondientes, especialmente en lo que se refiere a las lesiones de los órganos

de los sentidos.

Artículo 22.- Para ejercer el derecho establecido en el inciso 3.o del articulo 7.o de la ley N.o 16.744, los afiliados deberán solicitar del servicio Nacional de Salud se les practiquen los exámenes correspondientes. Este Servicio resolverá a través de las Comisiones señaladas en el articulo 4.o de este reglamento. La resolución respectiva deberá ser consultada por el organismo administrador a la Superintendencia de Segundad Social.

Artículo 23°En los siguientes casos las enfermedades profesionales se consideran que producen incapacidad temporal:

Enfermedades	Casos en que provoca incapacidad temporal
1) Intoxicaciones, causadas por los agentes químicos (1-18).	Fase aguda o subaguda de la enfermedad que requiere atención médica o cese del trabajo.
2) Dermatosis, causadas por diferentes agentes (1-16-17, 18, 19, 20 y 26).	Fase aguda o subaguda de la enfermedad que requiere atención médica o cese del trabajo.
3) Cánceres cutáneos, respiratorios, hepáticos y urinarios, causados por agentes físicos y químicos (1-18, 19, 20, asbesto y aminas aromáticas).	Durante el período de diagnóstico o de tratamiento.
4) Asma bronquial, bronquitis y neumonitis, enfisema y fibrosis pulmonar, causadas por agentes químicos y biológicos.	Fase aguda o subaguda de la enfermedad que requiere atención médica o cese del trabajo.
5) Enfermedades del sistema nervioso central y periférico: encefalitis, mielitis, neuritis y polineuritis, causadas por agentes químicos y físicos (1-18-19-23).	Incluida en la fase aguda o subaguda de las intoxi-caciones (1-18) o de la acción de agentes físi-cos (19-23).
6) Enfermedades de los órganos de los sentidos, causadas por agentes químicos y físicos (1-18, 19, 20 y 21).	Durante el período de diagnóstico y tratamiento inicial.
7) Neurosis y laringitis con afonía, causadas por trabajos que expongan al riesgo de tensión fisiológica y psíquica y se	Durante el período de diagnóstico y tratamiento inicial de la enfermedad.

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile / BCN | Ley Chile

compruebe relación de causa a efecto con el trabajo.	
8) Enfermedades de los órganos del movimiento: artritis, sinovitis tenonitis, miositis, celulitis, calambres y transtornos de la circulación y de la sensibilidad de las extremidades causadas por agentes diversos (9, 19, 22, 23 y 24).	Fase aguda o subaguda de la enfermedad que requiere atención médica o cese del trabajo.
9) Enfermedades infecto - contagiosas parasitarias, y por picaduras de insectos, causadas por agentes biológicos (24, 25).	Fase aguda de la enfermedad que requiere atención médica o cese del trabajo.

Artículo 24° Se entiende que las enfermedades profesionales producen invalidez en los casos que se definen a continuación. Las Comisiones a que se refiere el artículo 4 determinará, entre los porcentajes señalados, el grado de incapacidad física al que sumarán la ponderación contemplada en el artículo 60 de la ley Nº 16.744 y en los artículos 31 y siguientes de este reglamento para establecer la incapacidad de ganancia.

1) Intoxicaciones, causadas por los agentes químicos (1-18).	Fase crónica. Secuelas o complicaciones de las fases agudas y subagudas, de carácter permanente: a) Si incapacita principal-mente para el trabajo específico 40% a 65% b) Si incapacita para cualquier trabajo 70% a 90%
2) Dermatosis por diferentes agentes.	Fase crónica con lesiones irreversibles o lesio-nes desarrolladas en las fases agudas y subagudas: a.- Si incapacita principalmente para el trabajo específico, 40% a 65%. b.- Si incapacita para cualquier trabajo, 70% a 90%.
3) Carcinomas cutáneos, respiratorios, y urinarios, causados por agentes físicos y químicos (1-18, 19, 20, asbesto y aminas	I. Secuelas o complicaciones irreversibles, directas o indirectas (terapéuticas): a) Si incapacitan principalmente para

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile / BCN | Ley Chile

aromáticas).		el trabajo específico. ..40% a 65% b) Si incapacitan para cualquier trabajo ... 70% a 90% II. Casos irrecuperables ...90%
4) Neumoconiosis, causadas por los agentes 26, 27, 28, 29 y 30.		I. Todo caso radiológicamente bien establecido (polvos 27, 28, 29 y 30) o clínicamente diagnosticado (polvos 26) con insuficiencia respiratoria o complicaciones infecciosas: a) Si incapacita principalmente para el trabajo específico... 40% a 65% b) Si incapacita para cualquier trabajo ... 70% a 90% II. En los casos en que sólo exista comprobación radiológica o clínica se aplicará lo dispuesto en los artículos 71° de la ley 16744 y 17° de este reglamento... 25%
5) Asma bronquial, bronquitis y neumonitis, enfisema y fibrosis pulmonar, causadas por agentes químicos y biológicos.		I) Fase crónica e irreversible de la enfermedad con insuficiencia respiratoria: a.- Si incapacita principalmente para el trabajo específico...40% a 65%. b.- Si incapacita para cualquier trabajo.. 70% a 90%.
6) Enfermedades del sistema nervioso central y periférico: encefalitis, mielitis, neuritis y polineuritis, causadas por agentes químicos		I. Lesiones nerviosas que afecten a un territorio neurológico de las extremidades: se aplicará el

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile / BCN | Ley Chile

y físicos (1-18, 19, 23).		criterio del baremo de accidentes del trabajo.
	II.	Lesiones nerviosas que comprometan a otros órganos:
	a)	Si incapacitan principalmente para el trabajo específico.. 40% a 65%
	b)	Si incapacitan para cualquier trabajo ... 70% a 90%
7) Enfermedades de los órganos de los sentidos, causadas por agentes químicos y físicos (1-18, 19, 20 y 21).		Lesiones de carácter permanente, que produzcan un déficit sensorial:
	a)	Si incapacitan principalmente para el trabajo específico... 40% a 65%
	b)	Si incapacitan para cualquier trabajo ... 70% a 90%
8) Neurosis causada por trabajos que expongan al riesgo de tensión psíquica y que se compruebe relación de causa a efecto con el trabajo.		Fase crónica e irreversible de la enfermedad:
	a)	Si incapacita principalmente para el trabajo específico .. 40% a 65%
	b)	Si incapacita para cualquier trabajo ... 70% a 90%
9) Enfermedades de los órganos del movimiento: artritis, sinovitis, tenosinovitis, miositis, celulitis, calambres y trastornos circulación y de la sensibilidad de las extremidades, causadas por agentes diversos (9, 19, 22, 23 y 24).		Lesiones de los órganos del movimiento en su fase crónica e irreversible:
	a)	Si incapacitan principalmente para el trabajo específico .. 40% a 65%
	b)	Si incapacitan para cualquier trabajo ... 70% a 90%
10) Enfermedades infectocontagiosas, parasitarias y por picaduras de insectos, causadas por agentes		Fase crónica. Secuelas o complicaciones de las fases agudas y subagudas,

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile / BCN | Ley Chile

biológicos (24, 25).

de carácter permanente:

a) Si incapacita principalmente para el trabajo específico.. 40% a 65%

b) Si incapacitan para cualquier trabajo ... 70% a 90%

Artículo 25° Las Comisiones para determinar el grado de incapacidad física derivada de accidentes del trabajo, deberán atenerse a la siguiente tabla de porcentajes, a los que sumarán la ponderación contemplada en el artículo 60 de la ley N.o 16.744 y en los artículos 31 y siguientes de este reglamento para establecer la incapacidad de ganancia.

a) Miembros Superiores	
1.- Pérdidas de ambas manos o amputación de ellas en niveles altos	90%
2.- Amputación a través de la articulación del hombro	60%
3.- Anquilosis del hombro con omóplato fijo	40%
4.- Anquilosis del hombro con omóplato libre	35%
5.- Amputación bajo el hombro con muñón a menos con 20 cm desde el vértice del acromión	50%
6.- Amputación desde los 20 cm. del vértice del acromión amenos de 11,5 cm. bajo el vértice del olecranon	45%
7.- Pérdida de una mano. Pérdida del pulgar y 4 dedos de una mano. Amputación del antebrazo, 10 cm. por debajo del vértice del olecranon	40%
8.- Pérdida del dedo pulgar derecho o izquierdo y su metacarpiano	30%
9.- Pérdida del pulgar (1.a y 2.a falanges)	25%
10.- Pérdida de la segunda falange del pulgar	15%
11.- Pérdida del dedo índice (derecho o izquierdo)	20%
12.- Pérdida de la 2.a y 3.a falanges del índice	15%
13.- Pérdida de la tercera falange del índice	15%
14.- Pérdida del dedo medio (derecho o izquierdo)	20%
15.- Pérdida de la 2a. y 3a. falanges del dedo medio	15%
16.- Pérdida total de los dedos anular y meñique (derecho o izquierdo)	15%
b) Miembros Inferiores	
17.- Doble amputación a través del muslo o pierna, o amputación a través de muslo o pierna de un lado y pérdida de otro	

pie 90%
18.- Amputación de ambos pies, resultando en muñones de apoyo terminal ... 50%
19.- Amputación de ambos pies, proximales a la articulación metatarso-falángica 50%
20.- Pérdida de todos los ortejos de ambos pies a nivel de la articulación metatarso-falángica 30%
21.- Pérdida de todos los ortejos de ambos pies proximal a las articulaciones interfalángicas proximales 25%
22.- Pérdida de todos los ortejos de ambos pies, distal a la articulación inter-falángica proximal 20%
23.- Amputación a nivel de la cadera ... 60%
24.- Amputación bajo la cadera con muñón no mayor de 12,5 cm. desde el vértice del trocanter mayor 50%
25.- Amputación bajo la cadera con muñón de más de 12,5 cm. desde el vértice del trocanter mayor, pero que no sobrepase la mitad del muslo 45%
26.- Amputación bajo la mitad del muslo hasta 9 cm. bajo la rodilla 40%
27.- Amputación bajo la rodilla con muñón mayor de 9 cm. y no mayor de 13 cm. ... 35%
28.- Amputación bajo la rodilla con muñón mayor de 13 cm. 30%
29.- Amputación de un pie con muñón de apoyo terminal 25%
30.- Amputación de un pie proximal a la articulación metatarso-falángica ... 25%
31.- Pérdida de todos los dedos de un pie proximal a la articulación metatarso-falángica 15%
32.- Pérdida total del dedo mayor. De dos o tres dedos, con exclusión del dedo mayor y del menor 15%

c) Otras Lesiones

Organos de los sentidos

33.- Ceguera total 90%
34.- Pérdida o deficiencia de la visión:
a) Si incapacita principalmente para el trabajo específico ... ... 40% a 65%
b) Si incapacita para cualquier trabajo ... ... 70% a 90%
35.- Pérdida de un ojo sin complicaciones, con normalidad del otro 30%
36.- Pérdida de la visión de un ojo sin complicaciones siendo normal el otro ojo 25%
37.- Pérdida de la audición (Art. 21°) ... 15% a 65%
38.- Pérdida del equilibrio:
a) Si incapacita principalmente para el trabajo específico ... ... 40% a 65%
b) Si incapacita para cualquier trabajo ... ... 70% a 90%

Mutilaciones y Deformaciones

39.- Severas, en la cara o cabeza 35%

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile / BCN | Ley Chile

40.- Importantes, en los órganos genitales 35%

Invalideces Múltiples

Se aplicará lo dispuesto en el artículo 26° de este reglamento.

Artículo 26° Tratándose de invalideces múltiples las Comisiones procederán, previamente, a graduar cada una de las incapacidades físicas conforme a la tabla de porcentajes consignadas en el artículo anterior, considerándolas independientemente. Enseguida, se confeccionará una lista de ellas siguiendo el orden de mayor a menor, conforme a los porcentajes de incapacidad física asignados. Hecha la ordenación, el primero de dichos porcentajes servirá para determinar como capacidad física residual de trabajo la diferencia existente entre el 100% y el referido porcentaje. A continuación, se aplicará el porcentaje asignado a la segunda invalidez a la capacidad física residual de trabajo determinada anteriormente. El producto constituirá el grado de incapacidad física derivado de la segunda invalidez, el que será sumado al grado asignado a la primera invalidez.

Si hubiera una tercera invalidez, el porcentaje a ella asignado en la lista se aplicará sobre la capacidad física residual de trabajo representada, en este caso, por la diferencia existente entre la incapacidad resultante de la suma de las dos anteriores y el 100%. El producto constituirá el grado de incapacidad física derivado de la tercera invalidez, el que será sumado a los grados establecidos para las dos primeras invalideces.

Si hubiere otra u otras invalideces, se seguirá aplicando el mismo procedimiento.

En ningún caso, la suma total de las invalideces múltiples podrá exceder del 90%.

Una vez determinada, por este procedimiento, la incapacidad física global derivada de las invalideces múltiples, se aplicará, si procediere, la ponderación contemplada en el artículo 60 de la ley N° 16.744 y en los artículos 31 y siguientes de este reglamento para establecer la incapacidad de ganancia.

Para facilitar la aplicación de lo dispuesto en el presente artículo, el Servicio Nacional de Salud dictará los reglamentos internos que estime pertinentes.

Artículo 27° El mismo procedimiento contemplado en el artículo anterior se aplicará al hacer las reevaluaciones a que se refieren los artículos 61° y 62° de la ley 16.744, procediéndose en tal caso a evaluar nuevamente cada una de las invalideces.

Artículo 28° Para determinar el grado de las invalidaces no clasificadas en el presente reglamento, se considerarán los siguientes factores: a) Lesión anatómica fisiológica; b) Manifestaciones clínicas; c) Disminución de la capacidad de trabajo; d) Limitaciones por las condiciones de trabajo; e) Reacciones imponderables; f) Rapidez; g) Fuerza; h) Coordinación; i) Perseverancia, y j) Seguridad.

El Servicio Nacional de Salud dictará los reglamentos internos que estime procedentes para la correcta evaluación de estos casos.

Artículo 29° Artículo 29°- Para determinar, según los casos, las incapacidades físicas y de ganancia, las invalideces se fijarán en tramos de dos y medio en dos y medio grados hasta el 40%, y en tramos de cinco en cinco grados de el 40% adelante.

Para estos efectos, las fracciones resultantes de la aplicación de los factores de ponderación se ajustarán al tramo más cercano.

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile / BCN | Ley Chile

Artículo 30° Las indemnizaciones globales a que se refiere el artículo 35° de la ley 16.744, serán las siguientes:

% Incapacidad de ganancia	Monto Indemnización (sueldos base)
15,0	1,5
17,5	3,0
20,0	4,5
22,5	6,0
25,0	7,5
27,5	9,0
30,0	10,5
32,5	12,0
35,0	13,5
37,5	15,0

Artículo 31° Los factores de ponderación que se considerarán para determinar la incapacidad de ganancia serán: la edad, la profesión habitual y el sexo.

Artículo 32° Cuando el grado de incapacidad física asignado por este reglamento a una invalidez consistiera en un tramo oscilante entre un porcentaje mínimo y uno máximo, la ponderación incrementará el que se hubiere fijado hasta en un 10% del mismo si la edad del accidentado o enfermo profesional influyere en sus posibilidades de trabajo; hasta en un 10% del porcentaje de la incapacidad física que originariamente se hubiere señalado si lo afecta para el ejercicio de su labor o profesión habitual de acuerdo a su grado de capacitación y especialización; y hasta en un 5% aplicado sobre el mismo porcentaje antes indicado si su capacidad residual de trabajo resulta más adecuada para labores propias o habituales del sexo opuesto.

Artículo 33° En los casos en que el grado de incapacidad física establecido en este reglamento consistiere en un porcentaje único, los factores de ponderación antes enunciados servirán para aumentar o disminuir, hasta en un 5% tratándose de la edad o profesión habitual, o hasta en un 2,5% tratándose del sexo, el porcentaje fijado a la incapacidad física observándose en la aplicación de esta norma el mismo procedimiento señalado en el artículo anterior.

Artículo 34° Los factores de ponderación a que se refieren los artículos anteriores no son excluyentes entre sí y habilitarán, según el caso, a que la prestación económica del accidentado o enfermo profesional se transforme de indemnización en pensión de invalidez parcial, o de pensión de invalidez parcial en pensión de invalidez total.

En ningún caso la aplicación de los factores de ponderación servirá para transformar la invalidez total en gran invalidez.

Tómese razón, comuníquese, publíquese e insértese en la Recopilación que corresponda de la Contraloría General de la República.- E. FREI M.- Eduardo León Villarreal.- Alejandro Hales Jamarne.

Lo que transcribo a U. para su conocimiento.- Saluda a U.- Alvaro Covarrubias ?., Subsecretario de Previsión Social.